OBSERVATORIO DE ACTUALIDAD EN PSICOLOGÍA

Instituto Politécnico de Psicología

lunes 9 de noviembre de 2026

Resumen rápido del día

El Ministerio de Sanidad detalló el 22 de octubre las garantías de la Ley 4/2026 sobre intervenciones involuntarias en salud mental, en vigor desde el 23 de octubre: consentimiento informado, apoyos a la decisión, voluntades anticipadas y registro en la historia clínica. ConSalud recoge un estudio en 92 países, con 53.799 personas, según el cual los adultos jóvenes presentan menor bienestar que otros grupos de edad. La OPS/OMS describe la formación en mhGAP 2.0 de personal de primer nivel en 11 regiones sanitarias de Honduras. Infocop no ha publicado piezas nuevas desde el 6 de noviembre, por lo que este informe se apoya en fuentes oficiales y en otros medios.

Noticias nacionales

NORMATIVA · NACIONAL

Sanidad detalla las garantías de la reforma sobre intervenciones involuntarias en salud mental

El Ministerio de Sanidad informó el 22 de octubre de 2026 de que, al día siguiente, entraba en vigor la reforma recogida en la Ley 4/2026, que refuerza las garantías de los pacientes ante las intervenciones involuntarias en salud mental. Según la nota, toda intervención debe apoyarse en un consentimiento libre e informado conforme a la normativa de autonomía del paciente y, cuando la persona necesite apoyo para decidir, las decisiones deben tomarse con los apoyos formalmente establecidos, siguiendo el modelo de la Ley 8/2021. Si el paciente no puede decidir, deben consultarse sus voluntades anticipadas o la

información de su historia clínica, y se fomenta la planificación anticipada y los planes de crisis. El ingreso involuntario urgente se limita a casos de urgencia vital, es decir, de amenaza para la vida o la integridad de la persona o de terceros. Antes de ingresar, el personal debe agotar las alternativas voluntarias, consultar las voluntades anticipadas, ofrecer los apoyos necesarios y dar información accesible, y todo ello debe documentarse en la historia clínica. La norma prohíbe las intervenciones involuntarias protocolizadas sin valoración individual, las medidas prolongadas injustificadas y cualquier uso punitivo o disciplinario. Las sujeciones mecánicas solo se admiten en situaciones excepcionales, se tratan como incidente de seguridad del paciente, se registran y se revisan después. Según informa el diario Ara, sociedades científicas de psiquiatría como la SEPC y la SEPSM critican que la norma genera inseguridad jurídica, mientras que la comisionada de Salud Mental, Belén González, aclaró que los ingresos involuntarios seguirán realizándose.

Fuente: Ministerio de Sanidad (nota de prensa del 22 de octubre de 2026) y Ara

Noticias internacionales

INVESTIGACIÓN · INTERNACIONAL

Un estudio en 92 países sitúa a los adultos jóvenes con menor bienestar que otros grupos de edad

ConSalud informó el 4 de noviembre de 2026 de un estudio publicado en la revista Social Indicators Research, liderado por Kai Ruggeri, profesor de Política y Gestión Sanitaria en la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia. La muestra incluye 53.799 personas de 92 países. Según el medio, los adultos jóvenes presentan un bienestar significativamente menor que otros grupos de edad, de modo que la tradicional curva en U de la felicidad por edad ya no se sostiene. Las áreas más débiles son la vitalidad, la estabilidad emocional y la resiliencia, mientras que las relaciones, el sentido de la vida, la competencia, la implicación y la autoestima puntúan relativamente mejor. Los descensos se observan en regiones de renta alta, especialmente en países de la OCDE y del norte de Europa, y los investigadores señalan que la riqueza nacional por sí sola no garantiza una buena salud mental. Un mayor nivel de

ingresos y de estudios, el empleo, convivir con otras personas y el trabajo híbrido, frente al totalmente remoto, se asocian con más bienestar. El estudio plantea además que la salud mental no es solo la ausencia de enfermedad y que indicadores aislados de ansiedad, estrés o depresión no reflejan el bienestar de una población. El artículo no ofrece puntuaciones ni porcentajes concretos más allá del tamaño de la muestra, y la información procede de ConSalud, no de la publicación original.

Fuente: ConSalud (4 de noviembre de 2026), sobre un estudio de Social Indicators Research

SALUD PÚBLICA · INTERNACIONAL

La OPS/OMS forma en mhGAP 2.0 al personal de primer nivel en 11 regiones sanitarias de Honduras

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) informó el 5 de noviembre de 2026, desde Santa Rosa de Copán (Honduras), de que la Secretaría de Salud impulsa la preparación del personal del primer nivel de atención en 11 regiones sanitarias priorizadas por afectaciones humanitarias. La iniciativa cuenta con el apoyo del Fondo Humanitario para Honduras y la cooperación técnica de la OPS, e incluye municipios de departamentos fronterizos, donde la movilidad migratoria añade dificultades de acceso y continuidad de los servicios. Se utiliza la Guía de Intervención mhGAP 2.0, que orienta al personal no especializado a identificar, manejar y derivar condiciones prioritarias de salud mental, trastornos neurológicos y problemas por consumo de sustancias; la nota menciona el estrés agudo, el duelo, la depresión y el riesgo suicida. Entre el 2 y el 5 de noviembre se impartió una formación al personal de medicina, enfermería y psicología de la Región Sanitaria de Copán. La nota no informa del número de profesionales formados ni de la población atendida. El enfoque declarado es que el personal de primer nivel reconozca necesidades de salud mental, ofrezca una primera respuesta y facilite la derivación y el seguimiento cuando haga falta un especialista.

Fuente: OPS/OMS (5 de noviembre de 2026)

Prioridades del día

Consentimiento y apoyos a la decisión

Puede ser útil revisar si los modelos de consentimiento informado de la consulta recogen cómo se ofrecen los apoyos a la toma de decisiones cuando la persona los necesita.

Voluntades anticipadas y planes de crisis

Puede ser relevante explorar con pacientes de riesgo la planificación anticipada y los planes de crisis, que la reforma fomenta según la nota de Sanidad.

Registro en la historia clínica

Puede ser oportuno comprobar que la historia clínica deja constancia de las alternativas voluntarias ofrecidas y de los apoyos facilitados antes de cualquier medida no consentida.

© 2026 IPP | Instituto Politécnico de Psicología · Observatorio de Actualidad — lunes 9 de noviembre de 2026